SANGRADO DIGESTIVO ALTO Y BAJO

DR. ALFREDO MATOS

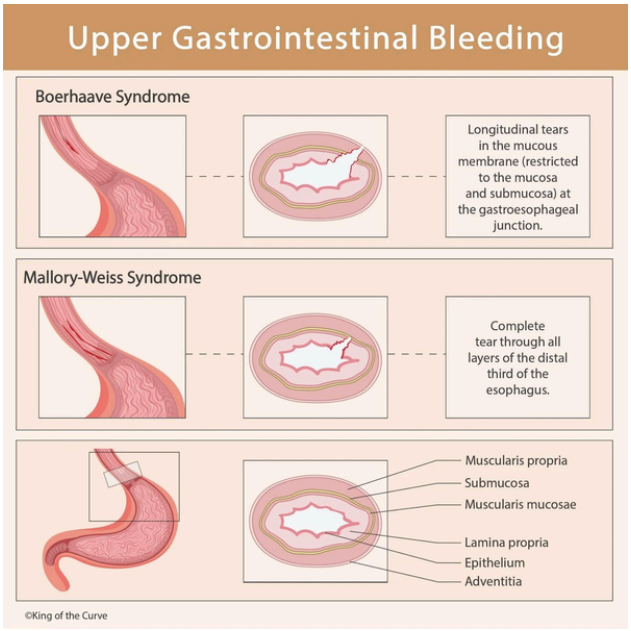
SANGRADO DIGESTIVO ALTO

CAUSAS DE SANGRADO DIGESTIVO ALTO

- Úlcera péptica (40–50%), gastritis erosiva y várices esofágicas por hipertensión portal.

DESGARRO DE MALLORY-WEISS

- Laceración mucosa lineal en la unión esofagogástrica por vómitos forzados.



LESIÓN DE DIEULAFOY

- Arteria submucosa aberrante de gran calibre que erosiona el epitelio: sangrado arterial masivo e intermitente.

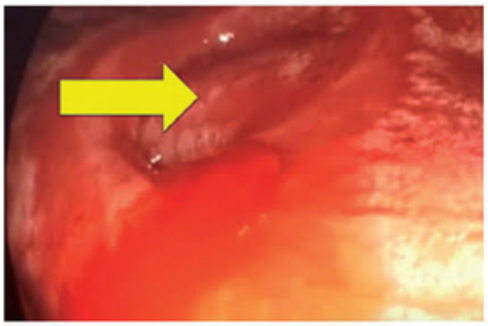
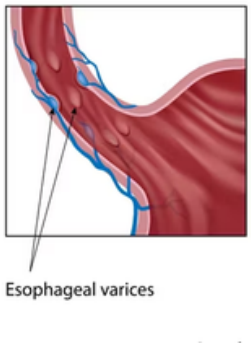
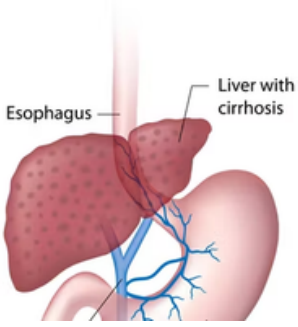


Figura 1. Lesión de Dieulafoy en duodeno pared posterior entre la primera y segunda porción.

VÁRICES ESOFÁGICAS

- Se asocian a hipertensión portal (cirrosis); el sangrado puede ser masivo.
- Tratamiento: ligadura endoscópica con bandas, vasoconstrictores esplácnicos (octreótido) y antibióticos profilácticos.
- Si no se controla: balón de Sengstaken-Blakemore o TIPS como rescate.





FORREST IA

- Sangrado activo arterial a chorro; resangrado ~90%.

FORREST IB

- Sangrado activo en napa (rezumante); resangrado ~30%.

FORREST IIA

- Vaso visible no sangrante; resangrado ~50%.

FORREST IIB

- Coágulo adherido; resangrado ~41%.

FORREST IIC

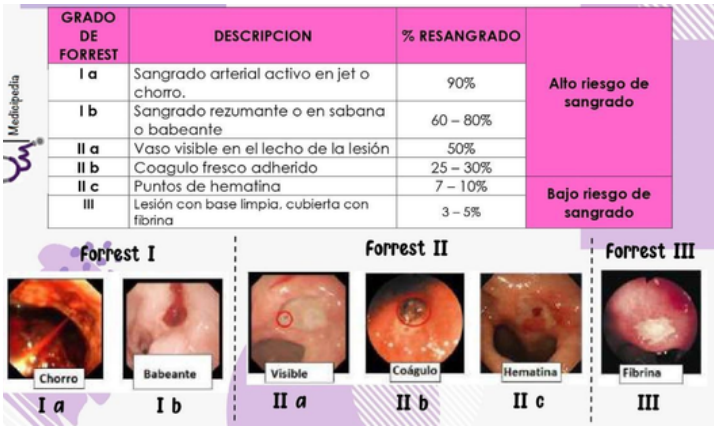
- Fondo con manchas de hematina; riesgo ~5%.

FORREST III

- Base limpia con fibrina; riesgo mínimo.

SANGRADO DIGESTIVO ALTO Y BAJO

DR. ALFREDO MATOS



TRANSFUSIÓN RESTRICTIVA

- Glóbulos rojos solo con Hb ≤7 g/dL (meta 7–9): menor mortalidad y resangrado que la estrategia liberal.

REVERSIÓN DE LA ANTICOAGULACIÓN

- Con warfarina: suspender y administrar complejo protrombínico o plasma fresco congelado más vitamina K.

CUÁNDO SOSPECHAR SANGRADO ACTIVO

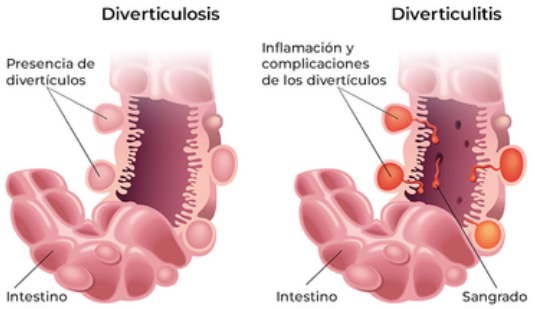
- Taquicardia persistente, caída del hematocrito o inestabilidad hemodinámica pese a la reanimación inicial obligan a repetir estudios o intervenir.
- La necesidad de transfusiones repetidas es señal de sangrado activo no controlado.

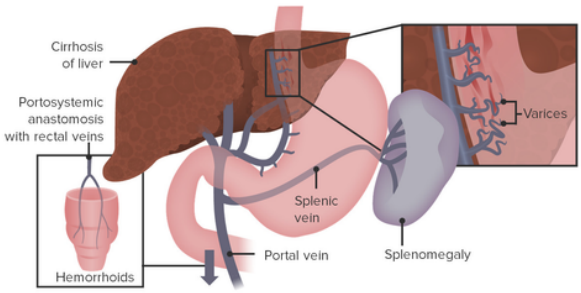
PREVENCIÓN DE RESANGRADO

- Segunda endoscopia programada si hubo alto riesgo de resangrado en la primera.
- El uso continuo de IBP reduce el riesgo de resangrado por úlcera péptica.
- Evitar AINEs y suspender anticoagulantes según el riesgo trombótico del paciente.

SANGRADO DIGESTIVO BAJO

- Causas más frecuentes: enfermedad diverticular, angiodisplasia, hemorroides, colitis y neoplasias.
- Presentación: hematoquecia (sangre roja por el recto); puede ser melena si el tránsito es lento.
- Manejo inicial: igual que en el sangrado alto; descartar siempre un origen alto si hay inestabilidad hemodinámica.





LOCALIZACIÓN Y TRATAMIENTO

- Colonoscopia: estudio de elección una vez estabilizado el paciente.
- Angio-TC o gammagrafía con eritrocitos marcados: en sangrado activo cuando la colonoscopia no localiza el origen.
- Cirugía: reservada para sangrado persistente no controlado por endoscopia o angiografía.